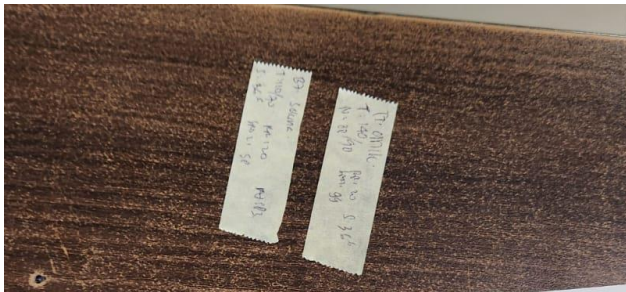


LAPORAN SUPERVISI DENGAN OBSERVASI RSPH Sukorejo

NO	TANGGAL	KEGIATAN	JUMLAH YANG DIPANTAU / OBSERVASI	HASIL TEMUAN	RTL	Keterangan
1.	Periode 9-14 Desember 2024	Observasi IGD	Unit IGD	- Batasan / indikasi pasien rujuk dikembalikan pada RKK dan SPK	-Apabila memang kondisi emergency maka dapat ditangani oleh EM apabila sudah lewat periode emergency maka dapat dirujuk sesuai indikasi DPJP utama	-sudah disampaikan pada direktur dan MOD terkait hal tersebut Evaluasi dan folup berkala selama 1 bulan
2.	Periode 9-14 Desember 2024	Observasi IGD	Unit IGD	-pendampingan saat pasien stabil untuk CXR yang dilakukan hanya oleh CS	-apabila saat kondisi overload maka untuk pendampingan tetap oleh 1 orang perawat dan 1 orang pekarya karena sangat berisiko tetap terkait dengan	-adanya pengawasan dari Kabid dan Karu terkait proses pendampingan CXR pasien

					keselamatan pasien bila hanya didampingi oleh pekarya atau CS	
3.	Periode 9-14 Desember 2024	Observasi IGD	Unit IGD	-Adanya penulisan buku operan pasien datang tidak menulis di kertas plester. 	-Lebih efisien, mudah terbaca, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan -bisa meminimalisir adanya kesalahan pada penulisan maupun miss pada TTV ataupun keluhan	-evaluasi sudah ada, namun masih belum berjalan dengan baik
4.	Periode 9-14 Desember 2024	Observasi IGD	Unit IGD	Sinkronisasi dan penggunaan DRM yang diperlukan tindakan print di IGD	-diperlukan untuk efisiensi waktu antara print lembar triage - usulan adalah dengan	-bekerja sama dengan TIM IT dan manajemen terkait beberapa usulan SIMRS agar efisien

					memanfaatkan billing DPJP sehingga apabila sudah dikerjakan oleh dokter umum maka di ruang rawat inap tinggal membuka billing DPJP utama -sinkronisasi dengan DRM rawat inap -diharapkan apabila sudah DRM hanya beberapa RM yang memerlukan TTD selain itu dapat berupa elektronik	
5.	Periode 9-14 Desember 2024	Observasi IGD	Unit IGD	-Alur pelayanan IGD, terkait mana yang masuk triage dan kemudian dipilah sesuai P berapa, kesesuaian dengan tindakan emergency, urgency dan non emergency non urgency.	-saran alur bisa ditempel dan kemudian sosialisasi pada seluruh tenaga di IGD sehingga	Evaluasi kebutuhan tenaga dengan SDM didasarkan

				-Jumlah tenaga dokter yang kurang terutama pada shift sore dengan jadwal 2-1-1	tidak menimbulkan kebingungan. Peran keamanan untuk mengarahkan pasien sehingga bisa diatur dengan baik. -saran melihat flow selama 2 minggu sampai 1 bulan bila memang tinggi terus saran untuk diberlakukan 2-2-1 untuk dokter jaga IGD namun dapat dievaluasi bila memang belum sesuai terkait jumlah pasien.	pada penilaian medis maupun non medis.
6.	Periode 9-14 Desember 2024	Observasi IGD	Unit IGD	-pasien dengan masalah utama yang sesuai harus dijadikan DPJP utama bukan masalah sekunder. Contoh pasien dengan KAD maka bisa dikonsulkan ke IPD dahulu daripada ke paru bila memang disertai dengan gagal napas	-adanya penerbitan SE sehingga menjadi dasar pelaksana di lapangan terkait penentuan	-evaluasi 1 bulan setelah berjalan aturan

				-dokter IGD masih sering bingung menentukan problem utama indikasi rawat inap sesuai edaran yang terbaru	masalah utama pada pasien. -saran adanya pertemuan dengan dokter IGD dan kepala instalasi terkait sosialisasi aturan terbaru sehingga dokter IGD paham dan tidak salah terkait indikasi rawat inap -meningkatkan komunikasi dengan management (MOD atau kbid pelayanan) sehingga meminimalisir adanya pending claim atau gagal claim bisa dengan membuat grup khusus terkait indikasi rawat inap sehingga komunikasi dokter IGD dan	
--	--	--	--	---	--	--

				-Adanya ketakutan dari Dokter IGD terkait indikasi MRS pasien sesuai dengan juknis yang terbaru, terutama dengan indikasi abdominal pain dan dan GEA, volume depletion	management dapat berjalan. - Pada beberapa kondisi tertentu sesuai dengan aturan PERMENKES dan BA yang terbaru harus disesuaikan. -saat MRS harus disesuaikan dengan indikasi yang ada. Apabila memang masih bisa untuk RJ dapat di KIE sesuai dengan kondisi.	
7.	Periode 9-14 Desember 2024	Observasi IGD	Unit IGD	-Lembar edukasi di IGD, sering tidak diisi	-Pada pasien dengan kondisi khusus yang memerlukan untuk pemberian informasi baik medis, rencana diagnosis dan terapi harus dituliskan di lembar KIE sehingga akan	Evaluasi kebutuhan tenaga dengan SDM didasarkan pada penilaian medis maupun non medis.

					terdokumentasi dengan baik.	
8.	Periode 9-14 Desember 2024	Observasi IGD	Unit IGD	-pasien rawat jalan >6 jam di RS dengan umum atau klaim asuransi selain BPJS	- Adanya SE kepada dokter IGD, MOD dan staf IGD terkait hal tersebut. Sehingga tidak menimbulkan multitafsir, apalagi bila memang ada kendala lain seperti sosial.	-evaluasi 1 bulan setelah berjalan aturan
9.	Periode 9-14 Desember 2024	Observasi IGD	Unit IGD	-Alur update pasien di IGD, jumlah total pasien sudah ada gform tapi tidak tahu dilaporkan pada siapa	-Memaksimalkan grup IGD untuk bisa mengirimkan laporan harian masing-masing shift sehingga terpantau termasuk jumlah kunjungan, rencana rujuk, alasan dirujuk (terutama pasien umum dan asuransi) -kontrol dari kabid pelayanan atau dokter verif	-evaluasi selama 2-4 minggu kemudian akan lihat kepatuhan

					terkait diagnosis yang sudah dibuat oleh dokter IGD sehingga akhir shift dilaporkan juga ke manajemen sehingga bila ada masalah mudah identifikasi	
10	Periode 9-14 Desember 2024	Observasi IGD	Unit IGD	-Mengorganisir perujuk dan juga untuk optimalisasi pasien rujukan RS PHS	-Memaksimalkan potensi gathering dan sosialisasi pada FKTP dengan jadwal yang berkala sehingga hubungan dengan FKTP dan bidan praktek mandiri baik dan komunikasi bisa berjalan	-evaluasi 1 bulan setelah berjalan aturan

Mengetahui
Direktur PT. Disa Prima Medika

dr. Sefrina Trisadi

Supervisor

dr. Adhya Aji Pratama



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

SUPERVISI MANAGEMENT IGD

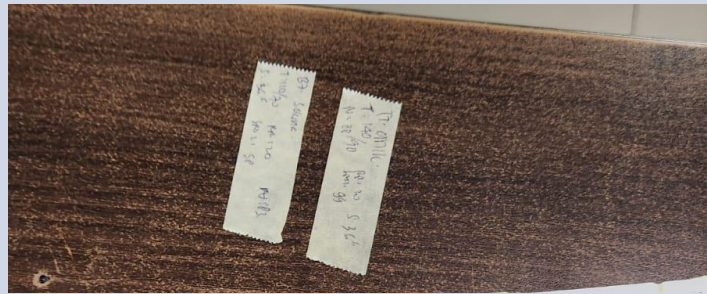
**PT DISA PRIMA MEDIKA | RS PRIMA HUSADA
SUKOREJO**

DESEMBER 2024

PERIODE 9-14 DESEMBER 2024

TEMUAN	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
- Batasan / indikasi pasien rujuk dikembalikan pada RKK dan SPK	-Apabila memang kondisi emergency maka dapat ditangani oleh EM apabila sudah lewat periode emergency maka dapat dirujuk sesuai indikasi DPJP utama	-sudah disampaikan pada direktur dan MOD terkait hal tersebut Evaluasi dan folup berkala selama 1 bulan
-pendampingan saat pasien stabil untuk CXR yang dilakukan hanya oleh CS	-apabila saat kondisi overload maka untuk pendampingan tetap oleh 1 orang perawat dan 1 orang pekaya karena sangat berisiko tetap terkait dengan keselamatan pasien bila hanya didampingi oleh pekaya atau CS	-adanya pengawasan dari Kabid dan Karu terkait proses pendampingan CXR pasien

PERIODE 9-14 DESEMBER 2024

TEMUAN	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
-Adanya penulisan buku operan pasien datang tidak menulis di kertas plester. 	-Lebih efisien, mudah terbaca, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan -bisa meminimalisir adanya kesalahan pada penulisan maupun miss pada TTV ataupun keluhan	-evaluasi sudah ada, namun masih belum berjalan dengan baik -sudah terdapat Buku TTV, sudah dituliskan namun kolom yang diisi salah (keluhan namun diisi identitas)
Sinkronisasi dan penggunaan DRM yang diperlukan tindakan print di IGD	-diperlukan untuk efisiensi waktu antara print lembar triage - usulan adalah dengan memanfaatkan billing DPJP sehingga apabila sudah dikerjakan oleh dokter umum maka di ruang rawat inap tinggal membuka billing DPJP utama -sinkronisasi dengan DRM rawat inap -diharapkan apabila sudah DRM hanya beberapa RM yang memerlukan TTD selain itu dapat berupa elektronik	-bekerja sama dengan TIM IT dan manajemen terkait beberapa usulan SIMRS agar efisien -sudah menerapkan DRM sejak dari IGD evaluasi 2 minggu – 1 bulan

PERIODE 9-14 DESEMBER 2024

TEMUAN	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
-Alur pelayanan IGD, terkait mana yang masuk triage dan kemudian dipilah sesuai P berapa, kesesuaian dengan tindakan. -Jumlah tenaga dokter yang kurang terutama pada shift sore dengan jadwal 2-1-1 -pasien dengan masalah utama yang sesuai harus dijadikan DPJP utama bukan masalah sekunder. Contoh pasien dengan KAD maka bisa dikonsulkan ke IPD dahulu daripada ke paru bila memang disertai dengan gagal napas -Dokter IGD masih sering bingung menentukan problem utama indikasi rawat inap sesuai edaran yang terbaru terutama dengan indikasi abdominal pain dan dan GEA, volume depletion	-saran alur bisa ditempel dan kemudian sosialisasi pada seluruh tenaga di IGD sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Peran keamanan untuk mengarahkan pasien sehingga bisa diatur dengan baik. -saran melihat flow selama 2 minggu sampai 1 bulan bila memang tinggi terus saran untuk diberlakukan 2-2-1 untuk dokter jaga IGD namun dapat dievaluasi bila memang belum sesuai terkait jumlah pasien. -adanya penerbitan SE sehingga menjadi dasar pelaksana di lapangan terkait penentuan masalah utama pada pasien. -saran adanya pertemuan dengan dokter IGD dan kepala instalasi terkait sosialisasi aturan terbaru sehingga dokter IGD paham dan tidak salah terkait indikasi rawat inap -meningkatkan komunikasi dengan management (MOD atau kabid pelayanan) grup khusus terkait indikasi rawat inap sehingga komunikasi dokter IGD dan management dapat berjalan.	Evaluasi kebutuhan tenaga dengan SDM didasarkan pada penilaian medis maupun non medis. -evaluasi 1 bulan setelah berjalan aturan

PERIODE 23-27 DESEMBER 2024

TEMUAN	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
-Lembar edukasi di IGD, sering tidak diisi	-Pada pasien dengan kondisi khusus yang memerlukan untuk pemberian informasi baik medis, rencana diagnosis dan terapi harus dituliskan di lembar KIE sehingga akan terdokumentasi dengan baik.	Evaluasi kebutuhan tenaga dengan SDM didasarkan pada penilaian medis maupun non medis.
-pasien rawat jalan >6 jam di RS dengan umum atau klaim asuransi selain BPJS	- Adanya SE kepada dokter IGD, MOD dan staf IGD terkait hal tersebut. Sehingga tidak menimbulkan multitafsir, apalagi bila memang ada kendala lain seperti sosial.	-evaluasi 1 bulan setelah berjalan aturan

PERIODE 23-27 DESEMBER 2024

TEMUAN	Rencana Tindak Lanjut	Keterangan
-Alur update pasien di IGD, jumlah total pasien sudah ada gform tapi tidak tahu dilaporkan pada siapa	-Memaksimalkan grup IGD untuk bisa mengirimkan laporan harian masing-masing shift sehingga terpantau termasuk jumlah kunjungan, rencana rujuk, alasan dirujuk (terutama pasien umum dan asuransi) -kontrol dari kabid pelayanan atau dokter verif terkait diagnosis yang sudah dibuat oleh dokter IGD sehingga akhir shift dilaporkan juga ke manajemen sehingga bila ada masalah mudah identifikasi	-evaluasi selama 2-4 minggu kemudian akan lihat kepatuhan
-Mengorganisir perujuk dan juga untuk optimalisasi pasien rujukan RS PHS	- Memaksimalkan potensi gathering dan sosialisasi pada FKTP dengan jadwal yang berkala sehingga hubungan dengan FKTP dan bidan praktek mandiri baik dan komunikasi bisa berjalan	-evaluasi 1 bulan setelah berjalan aturan